



Fièvre d'origine inconnue

Par [Larry M. Bush](#), MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

[Maria T. Vazquez-Pertejo](#), MD, FACP, Wellington Regional Medical Center

Reviewed By [Brenda L. Tesini](#), MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Vérifié/Révisé juil. 2024

Une fièvre d'origine inconnue (FUO) est définie par une température corporelle rectale $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ qui ne résulte pas d'une maladie transitoire et autolimitée, d'une maladie rapidement fatale, ou de troubles avec des symptômes ou signes de localisation évidents, ou avec des anomalies observées sur des examens courants tels que la radiographie thoracique, l'ECBU ou les hémocultures.

Les fièvres d'origine inconnue sont actuellement classées en 4 catégories distinctes (1):

- **Fièvre d'origine inconnue classique:** fièvre évoluant depuis > 3 semaines sans étiologie identifiée après 3 jours d'hospitalisation ou ≥ 3 consultations
- **Fièvre d'origine inconnue associée aux soins:** fièvre chez un patient hospitalisé recevant des soins aigus et n'ayant aucune infection présente ou en incubation à l'admission si le diagnostic reste incertain après 3 jours d'évaluation appropriée.
- **Fièvre d'origine inconnue liée à une immunodéficience:** fièvre en cas de neutropénie et d'autres [déficits immunitaires](#) (p. ex., transplantation d'organes et de cellules hématopoïétiques), si la cause de la fièvre reste incertaine après 3 jours d'évaluation appropriée, y compris cultures négatives après 48 heures; dans le cas d'une fièvre d'origine inconnue liée au VIH, fièvre pendant > 4 semaines en ambulatoire avec [infection par le VIH](#) confirmée ou > 3 jours chez le patient hospitalisé avec infection par le VIH confirmée si la cause de la fièvre reste incertaine après un bilan approprié
- **Fièvre d'origine inconnue liée aux voyages:** la reconnaissance des infections potentiellement mortelles ou transmissibles liées aux voyages doit être une priorité

Référence générale

1. [Haidar G, Singh N](#). Fever of Unknown Origin. *N Engl J Med*. 2022;386(5):463-477.
doi:10.1056/NEJMra2111003

Étiologie de la fièvre d'origine inconnue

Les causes de fièvre d'origine inconnue sont généralement classées en 4 catégories (voir tableau [Certaines causes de fièvre d'origine inconnue](#)) dont les fréquences ont varié au fil du temps et sont

influencées par l'âge, la géographie et les pathologies individuelles sous-jacentes (les pourcentages indiqués se rapportent aux adultes) (1):

- Infectieuses (25 à 50%)
- Troubles rhumatismaux systémiques (10 à 20%)
- Néoplasies (2 à 25%)
- Divers (15 à 25%)

Les **infections** sont la cause la plus fréquente des fièvres d'origine inconnue. Chez les patients infectés par le VIH, des infections opportunistes (p. ex., tuberculose; infection par des mycobactéries atypiques, les champignons disséminés, le cytomégalovirus) doivent être recherchées.

Les **troubles rhumatismaux systémiques fréquents** comprennent le [lupus érythémateux disséminé](#), la [polyarthrite rhumatoïde](#), l'[artérite à cellules géantes](#), la [pseudo-polyarthrite rhizomélique](#), la [vascularite](#) et la [polyarthrite rhumatoïde juvénile de l'adulte](#) (maladie de Still de l'adulte).

Les **causes néoplasiques les plus fréquentes** sont les lymphomes, les leucémies, le carcinome à cellules rénales, le carcinome ovarien, le myxome auriculaire, la maladie de Castleman, le carcinome hépatocellulaire et les cancers métastasés. Cependant, l'incidence des causes néoplasiques de fièvre d'origine inconnue a diminué, probablement parce que ces néoplasies sont détectées par l'échographie et la TDM, qui sont maintenant largement utilisées lors de l'évaluation initiale de la fièvre.

Les **causes diverses importantes** comprennent les réactions médicamenteuses, la [thrombose veineuse profonde](#), les [embolies pulmonaires](#) récidivants, la [thyroïdite](#), la [sarcoïdose](#), les [maladies intestinales inflammatoires](#) et la [fièvre factice](#).

La cause de la fièvre d'origine inconnue reste inconnue chez près de 10% des adultes.

TABLEAU		
Certaines causes de fièvre d'origine inconnue		
Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
Infectieuse		
Abcès (abdominaux, pelviens, dentaires)	Douleur abdominale ou pelvienne, habituellement douleur	TDM ou IRM
	Parfois, antécédents de chirurgie, traumatisme, diverticulose, péritonite ou manœuvres gynécologiques	

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Maladie des griffes du chat</u>	Antécédents de griffure ou de léchage par un chat Adénopathie régionale, syndrome oculoglandulaire de Parinaud, céphalées	Cultures (parfois de lymphé obtenue par aspiration de ganglion), examens sérologiques, PCR
<u>Infection à CMV</u>	Antécédents de transfusion sanguine provenant d'un donneur CMV-positif Syndrome qui ressemble à une mononucléose (asthénie, hépatite modérée, splénomégalie, adénopathies), chorioretinite	Titre d'IgM anti-CMV Éventuellement test de réaction en chaîne par polymérase
<u>Infection par le virus Epstein-Barr</u>	Amygdalo-pharyngite, adénopathies, douleur de l'hypochondre droit, splénomégalie, asthénie Habituellement observés chez les adolescents et jeunes adultes Chez les patients âgés, les signes typiques peuvent être absents	Tests sérologiques
<u>Infection par le VIH</u>	Antécédents de comportements à risque (p. ex., pratiques sexuelles non protégées, échange d'aiguilles souillées) Perte de poids, sueurs nocturnes, asthénie, adénopathies, infections opportunistes	Test immunologique combiné de 4e génération Parfois, des tests pour l'ARN du VIH (pour l'infection aiguë par le VIH)

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Endocardite infectieuse</u>	Souvent antécédent de facteurs de risque (p. ex., cardiopathie structurelle, valvules cardiaques prothétiques, parodontite, cathéter IV, consommation de drogues illicites injectées) Habituellement, un souffle cardiaque, parfois des manifestations extracardiaques (p. ex., hémorragies en flammèches, taches de Roth, nodules d'Osler, lésions de Janeway, douleurs ou épanchement articulaires, splénomégalie)	Hémocultures sérielles, échocardiographie
<u>Maladie de Lyme</u>	Voyage ou résidence dans une région où la maladie est endémique Érythème migrant, céphalées, asthénie, paralysie faciale à frigore (ou de Bell), méningite, radiculopathie, bloc auriculoventriculaire cardiaque, douleur et tuméfaction articulaire	Tests sérologiques
<u>Ostéomyélite</u>	Douleur localisée, tuméfaction, érythème	Radiographies (si subaiguë ou chronique) Parfois IRM (examen le plus précis), scintigraphie à l'indium-111, scintigraphie osseuse
<u>Sinusite</u>	Congestion, céphalées,	TDM des sinus

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	douleur faciale	
<u>Tuberculose</u> (pulmonaire et <u>disséminée</u>)	Antécédent d'exposition à haut risque Toux, perte de poids, asthénie Prise d'immunodépresseurs Antécédent d'infection par le VIH	Radiographie thoracique, intradermo-réaction à la tuberculine, test de libération de l'interféron gamma Analyse des crachats à la recherche de bacilles acido-résistants, test d'amplification des acides nucléiques, culture des liquides (p. ex., aspirats gastriques, expectoration, liquide céphalorachidien)
Infections rares (p. ex., <u>brucellose</u> , <u>paludisme</u> , <u>fièvre Q</u> , <u>toxoplasmose</u> , <u>trichinose</u> , <u>fièvre typhoïde</u>)	Antécédents de voyages en régions d'endémies Exposition ou ingestion de certains produits animaux	Tests sérologiques pour des causes spécifiques Frottis de sang périphérique pour le paludisme
Maladie rhumatismale systémique		
Maladie de Still de l'adulte	Exanthème fugace rose saumon, arthralgies, arthrites, myalgies, adénopathies cervicales, pharyngite, toux, douleur thoracique	AAN, facteur rhumatoïde, ferritinémie, radiographies des articulations atteintes
<u>Artérite (temporale) à cellules géantes</u>	Céphalée unilatérale, troubles visuels Souvent les symptômes de la pseudo-polyarthrite rhizomélitique, parfois claudication de la mâchoire Sensibilité de l'artère temporale à la palpation	VS, biopsie de l'artère temporale

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Polyartérite noueuse</u>	Fièvre, perte de poids, myalgies, arthralgies, purpura, hématurie, douleurs abdominales, douleurs testiculaires, angor, livédo réticulé (reticularis), HTA d'apparition récente	Biopsie ou angiographie des tissus atteints
<u>Pseudo-polyarthrite rhizomélique</u>	Antécédents de raideur matinale des épaules, hanches et du cou Malaise, fatigue, anorexie Parfois, synovite, bursite, œdème prenant le godet au niveau des extrémités	Créatine kinase, AAN, facteur rhumatoïde, VS Éventuellement IRM des membres
<u>Arthrites réactionnelles</u>	Parfois, antécédent d'infection à <i>Chlamydia</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Campylobacter</i> , ou <i>Shigella</i> Atteintes oligoarticulaires asymétriques, urétrite, conjonctivite, ulcérations génitales	AAN, facteur rhumatoïde, test sérologique de recherche de pathogènes bactériens
<u>Polyarthrite rhumatoïde</u>	Polyarthrite symétrique périphérique, raideur matinale prolongée, nodules cutanés rhumatoïdes au niveau des sites de pression (face d'extension des cubitus, sacrum, occiput, tendon d'Achille)	AAN, facteur rhumatoïde, anticorps anti-peptides anticycliques citrullinés (anti-CCP), radiographies (pour identifier des érosions osseuses)
<u>Lupus érythémateux disséminé</u>	Asthénie, arthralgie, douleur thoracique pleurale, exanthème maculeux, articulations tuméfiées et	Critères cliniques, AAN, anticorps anti-ADN double brin

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	douloureuses, œdèmes périphériques modérés, syndrome de Raynaud, sérosité, néphrite, alopecie	
Néoplasiques		
Un myxome de l'oreillette	Dyspnée, embolies occasionnelles provoquant des symptômes neurologiques	Échocardiographie
Maladie de Castleman	augmentation du volume des ganglions lymphatiques	Biopsie de ganglion lymphatique
Cancer du côlon	Douleurs abdominales, modification du transit intestinal, diarrhée sanglante, asthénie, nausées, vomissements, perte de poids, fatigabilité	Coloscopie, biopsie
Hépatome	Antécédents d'hépatopathie chronique, de douleurs abdominales, perte de poids, satiété précoce, masse palpable de l'hypochondre droit	Échographie et TDM abdominale, biopsie hépatique
Leucémie	Parfois, antécédents d'affection myélodysplasique Asthénie, perte de poids, hémorragie, pâleur, pétéchies, ecchymoses, anorexie, splénomégalie, douleurs osseuses	NFS, examen de la moelle osseuse
Lymphome	Adénopathie indolore, perte de poids, sensation de malaise, sueurs nocturnes, splénomégalie, hépatomégalie	Biopsie de ganglion lymphatique

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Cancer métastatique</u>	Symptômes dépendant du siège de la métastase (p. ex., toux et dyspnée en cas de métastases pulmonaires, céphalées et vertiges en cas de métastases cérébrales) Souvent asymptomatiques, découvertes au cours d'un contrôle médical de routine	Biopsie des masses ou adénopathies suspectes, imageries guidées par la clinique
<u>Troubles myéloprolifératifs</u>	Fréquemment asymptomatiques, anomalies incidemment détectées à l'occasion d'une NFS	Examens complémentaires basés sur la maladie suspectée
<u>Carcinome de l'ovaire</u>	Masse annexielle, douleur pelvienne	Échographie
<u>Carcinome à cellules rénales</u>	Perte de poids, sueurs nocturnes, douleurs de l'hypochondre, hématurie, masse palpable de l'hypochondre, HTA	Calcémie (pour une hypercalcémie), analyse d'urines, TDM des reins
Divers		
<u>Cirrhose alcoolique</u>	Antécédents d'alcoolisme chronique Parfois, ascite, ictère, hépatomégalie plus ou moins importante, gynécomastie, maladie de Dupuytren, atrophie testiculaire	Temps de prothrombine/temps de thromboplastine partielle, phosphatase alcaline, transaminases, albumine, bilirubine Parfois, échographie et TDM abdominale
<u>Thrombose veineuse profonde</u>	Douleur, tuméfaction, parfois une rougeur de jambe	Échographie Parfois dosage de D-dimère

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
Fièvre médicamenteuse	Fièvre qui coïncide avec l'administration d'un médicament (habituellement dans les 7–10 jours) Parfois, une éruption	Arrêt du médicament
<u>Fièvre factice</u>	Présentation dramatique, atypique, détails vagues et incohérents, bonne connaissance des signes cliniques livresques, état compulsif ou hypomaniaque (pseudologia fantastica)	Diagnostic d'exclusion
<u>Maladie intestinale inflammatoire</u>	Douleur abdominale, diarrhée (parfois sanglante), perte de poids, selles positives au gaïac Parfois, fistules, péri-anales et ulcérations buccales, arthralgies	Endoscopie œsogastroduodénale et de tout le tube digestif ou entéro-TDM (maladie de Crohn) Coloscopie (rectocolite ulcéro-hémorragique ou maladie de Crohn)
Thyroïdite	Nervosité, palpitations, augmentation de la transpiration, hypersensibilité à la chaleur, fatigue, augmentation de l'appétit, perte de poids et ophtalmopathie et dermopathie infiltratives (maladie de Graves-Basedow)	T4, TSH, auto-anticorps antithyroïdiens

*Les patients qui présentent une fièvre d'origine inconnue peuvent ne pas avoir de signes typiques, mais de tels signes doivent être recherchés.

AAN = anticorps antinucléaires; CMV = cytomégalovirus; T4 = thyroxine; TSH = thyroid-stimulating hormone.

Référence pour l'étiologie

1. [Fusco FM, Pisapia R, Nardiello S, Cicala SD, Gaeta GB, Brancaccio G](#). Fever of unknown origin (FUO): which are the factors influencing the final diagnosis? A 2005-2015 systematic review. *BMC Infect Dis*. 2019;19(1):653. Published 2019 Jul 22. doi:10.1186/s12879-019-4285-8

Évaluation d'une fièvre d'origine inconnue

Dans les cas difficiles, comme une fièvre d'origine inconnue, supposer que toutes les informations ont été recueillies avec précision par les médecins précédents est généralement une erreur. Les médecins doivent être informés de ce que les patients ont auparavant rapporté (pour analyser les divergences) mais ne doivent pas simplement recopier les détails de l'anamnèse précédente (p. ex., antécédents familiaux, antécédents sociaux). Des erreurs initiales par omission sont perpétuées par l'intermédiaire de nombreux médecins sur plusieurs jours d'hospitalisation, ce qui induit la pratique de beaucoup d'examens inutiles. Même lorsque le bilan initial a été correctement réalisé, il apparaît nécessaire de réinterroger les patients qui souvent se souviennent ainsi de nouveaux détails.

Inversement, les médecins ne doivent pas ignorer les résultats d'examens complémentaires déjà réalisés et ne doivent pas répéter ces examens en imaginant qu'ils seront différents (p. ex., parce que l'état du patient a changé, parce qu'une maladie se développe lentement).

Anamnèse

L'interrogatoire sur les antécédents a pour objectif de rechercher des signes cliniques focaux et des détails (p. ex., voyages, profession, antécédents familiaux, exposition des vecteurs, antécédents alimentaires) qui orientent vers une étiologie (1).

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit rechercher à caractériser la durée et l'aspect (p. ex., intermittente, constante) de la fièvre. L'évolution de la fièvre n'a habituellement peu ou aucune signification dans l'orientation du diagnostic des fièvres d'origine inconnue, bien qu'une fièvre survenant 1 jour/2 (tierce) ou 1 jour/3 (quarte) peut évoquer un [paludisme](#) en cas de facteurs de risque. Des douleurs focales permettent souvent la localisation (bien que pas la cause) de l'affection responsable. Les médecins doivent poser des questions de manière générale, puis spécifiquement, sur l'inconfort dans chaque partie du corps.

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes non spécifiques, tels qu'une perte de poids, une anorexie, une asthénie, des sueurs nocturnes et des céphalées. De plus, les symptômes associés

aux troubles rhumatismaux systémiques (p. ex., myalgies, arthralgies, éruptions cutanées) et les troubles digestifs (p. ex., diarrhée, stéatorrhée, douleur abdominale) doivent être recherchés.

La recherche des **antécédents médicaux** doit porter sur des troubles connus pour causer de la fièvre, tels que le cancer, la tuberculose, les troubles rhumatismaux systémiques, la cirrhose alcoolique, les maladies intestinales inflammatoires, le rhumatisme articulaire aigu et l'hyperthyroïdie. Les médecins doivent noter les troubles ou les facteurs prédisposant à l'infection, tels qu'une immunosuppression (p. ex., due à des troubles tels qu'une infection à VIH, un cancer, un diabète ou un traitement immunosuppresseur), une insuffisance cardiaque, des anomalies des voies urinaires, des antécédents chirurgicaux et l'insertion de dispositifs (p. ex., cathéters IV, pacemakers, prothèses articulaires).

L'**anamnèse médicamenteuse** doit inclure des questions sur des médicaments spécifiques connus pour causer de la fièvre.

L'**anamnèse sociale** doit également rechercher des facteurs de risque tels l'utilisation de drogues IV, des pratiques sexuelles à risque (p. ex., rapports sexuels non protégés, partenaires multiples), un contact avec des sujets infectés (p. ex., qui ont une tuberculose), des voyages et de possibles expositions à des animaux ou à des insectes et tiques vecteurs. L'anamnèse sociale doit également comprendre des questions sur les antécédents de maladie dans les contacts sociaux (p. ex., voisins, collègues, compagnons de voyage). Les facteurs de risque de cancer, comme le tabagisme, l'alcool et l'exposition professionnelle à des substances chimiques, doivent également être identifiés.

L'**anamnèse familiale** doit rechercher des causes héréditaires de fièvre (p. ex., [fièvre méditerranéenne familiale](#)).

Les dossiers médicaux sont relus à la recherche d'examens complémentaires anciens, en particulier ceux qui permettent d'éliminer certains troubles.

Référence de l'anamnèse

1. [Haidar G, Singh N](#). Fever of Unknown Origin. *N Engl J Med*. 2022;386(5):463-477.
doi:10.1056/NEJMra2111003

Examen clinique

L'état général, en particulier une cachexie, un ictère et une pâleur, est noté.

La peau est soigneusement inspectée à la recherche d'un érythème focal (suggérant un site d'infection) et d'une éruption (p. ex., éruption malaire du lupus érythémateux disséminé); l'inspection doit comprendre le périnée et les pieds, en particulier chez les diabétiques, qui sont sujets à des infections occultes à ce niveau. Il faut également rechercher des signes cutanés en faveur d'une endocardite, dont des nodules érythémateux sous-cutanés douloureux des extrémités des doigts (nodule d'Osler), des macules hémorragiques non douloureuses sur les paumes des mains ou les plantes des pieds (lésions de Janeway), des pétéchies et des hémorragies en flammèches sous les ongles.

Le corps entier (en particulier au-dessus du rachis, les os, les articulations, l'abdomen et la thyroïde) est palpé à la recherche de zones douloureuses, de tuméfactions ou d'une organomégalie; un toucher

rectal et un examen pelvien complètent l'examen clinique. Au cours de l'examen, toute adénopathie régionale ou systémique est observée; p. ex., une adénopathie régionale est caractéristique de la maladie des griffes du chat à l'inverse à des adénopathies diffuses du lymphome. Les dents sont percutées à la recherche d'une sensibilité (évoquant la présence d'abcès).

Le cœur est ausculté à la recherche de souffles (évoquant une [endocardite](#) bactérienne) et de frottements (évoquant une [péricardite](#) due à une pathologie rhumatologique ou infectieuse).

Parfois, des anomalies cliniques importantes chez les patients qui présentent une fièvre d'origine inconnue sont ou semblent si subtiles que la répétition des examens cliniques peut être nécessaire pour évoquer des causes possibles (p. ex., par la détection de nouvelles adénopathies, d'un souffle cardiaque, d'une éruption cutanée, ou de nodules et de pulsations faibles de l'artère temporale).

Signes d'alarme

Les suivants sont particulièrement préoccupants:

- Immunodépression
- Souffle cardiaque
- Présence de matériel étranger (p. ex., cathéters IV, pacemakers, prothèses articulaires)
- Voyage récent dans les zones où les maladies sont endémiques

Interprétation des signes

Après un interrogatoire et un examen clinique complet, les causes suivantes peuvent être considérées comme évidentes:

- Localiser des symptômes ou des signes qui n'étaient pas présents, pas détectés ou pas recherchés au cours d'examens cliniques antérieurs. Ces signes sont interprétés et étudiés comme indiqué (voir tableau [Certaines causes de fièvre d'origine inconnue](#)).
- En général, l'examen clinique ne détecte que des signes non spécifiques qui peuvent être présents dans de nombreuses fièvres d'origine inconnue, mais il identifie des facteurs de risque qui peuvent orienter les examens complémentaires (p. ex., voyage dans une région endémique, exposition à des vecteurs animaux, à des tiques et à des insectes). Parfois, les facteurs de risque sont moins spécifiques mais peuvent orienter vers une famille de maladies; p. ex., une perte de poids sans anorexie est plus compatible avec une infection qu'avec un cancer, qui habituellement provoque une anorexie. Les principales causes possibles doivent être recherchées de manière plus approfondie.
- Dans le plus difficile des scénarios, les patients n'ont aucun signe spécifique, aucun facteur de risque, ou des facteurs de risque multiples, rendant une approche diagnostique logique, séquentielle des tests, essentielle. Les examens complémentaires initiaux permettent de restreindre le champ diagnostique et guident la prescription des examens complémentaires suivants.

Examens complémentaires

Les résultats des tests précédents, en particulier des cultures, sont consignés. Les cultures pour certains microorganismes peuvent nécessiter une longue période avant de devenir positifs et des techniques spéciales peuvent être nécessaires. Un laboratoire de microbiologie doit être consulté sur les conditions de culture (p. ex., durée d'incubation, milieux spéciaux, température, environnement gazeux) qui peuvent être nécessaires.

Autant que possible, l'interrogatoire et l'examen clinique guident la prescription de ces examens complémentaires (voir tableau [Certaines causes de fièvre d'origine inconnue](#)). Par exemple, les patients âgés vivant en institution et qui présentent des céphalées ne doivent pas subir de recherche d'une infection transmise par les tiques ou du paludisme, mais ces maladies doivent être très sérieusement évoquées chez les sujets jeunes, les voyageurs qui ont fait des randonnées, exploré des cavernes ou pratiqué des sports aquatiques dans une région où la maladie est endémique. Un bilan à la [recherche d'une artérite à cellules géantes](#) est nécessaire chez les patients âgés; mais généralement pas chez les patients jeunes.

En plus des tests spécifiques, les examens suivants doivent habituellement être effectués:

- Numération formule sanguine
- Vitesse de sédimentation érythrocytaire, protéine C réactive, procalcitonine, lactate déshydrogénase (LDH) et ferritine
- Tests hépatiques
- Analyse d'urine avec examen microscopique
- Séries d'hémocultures (idéalement avant le traitement antibiotique)
- Test des anticorps anti-VIH, mesure des concentrations d'ARN et PCR
- Intradermo-réaction à la tuberculine ou test de libération de l'interféron gamma

Même si précédemment réalisés, ces tests peuvent être utiles.

L'ECBU et la radiographie de thorax habituellement déjà effectués, ne sont répétés que si des signes indiquent qu'ils sont nécessaires.

Tout liquide ou matériel provenant d'une zone suspecte d'infection doit être mis en culture (p. ex., pour mettre en évidence les bactéries, mycobactéries, champignons, virus, ou des bactéries nécessitant des cultures particulières). Des examens spécifiques des microorganismes, tels que la PCR et des sérologies (phase aiguë et convalescence), sont utiles principalement lorsqu'il existe un fort doute reposant sur une suspicion clinique. En aucun cas, ils ne doivent être prescrits de façon empirique.

Les tests sérologiques, tels que le dosage des anticorps antinucléaires (AAN) et du facteur rhumatoïde, sont effectués pour dépister les troubles rhumatologiques.

L'**imagerie** est guidée par la symptomatologie. Typiquement, les zones d'inconfort doivent être imagées (p. ex., en cas de douleurs dorsales, IRM de la colonne vertébrale avec injection de produit de contraste pour rechercher une infection ou une tumeur; en cas de douleurs abdominales, TDM abdominale avec injection de produit de contraste). Cependant, une TDM du thorax et abdomino-pelvienne est indiquée à la recherche d'adénopathies et d'abcès occultes même en l'absence de symptomatologie localisatrice.

Lorsque les hémocultures sont positives, si un souffle cardiaque apparaît ou des signes périphériques évocateurs d'endocardite, une échocardiographie est effectuée.

En général, la TDM est utile pour rechercher des troubles localisés au niveau de l'abdomen, du bassin ou du thorax.

L'IRM est plus sensible que la TDM pour la détection de la plupart des causes de fièvre d'origine inconnue atteignant le système nerveux central et doit être effectuée si une atteinte du système nerveux central est évoquée.

Un échodoppler veineux peut être utile pour identifier une [thrombose veineuse profonde](#).

La scintigraphie, en particulier avec des granulocytes marqués à l'indium-111, permet de localiser de nombreux processus infectieux ou inflammatoires, mais est désormais rarement utilisée, car l'IRM est extrêmement sensible. Mais cette technique n'est plus que rarement effectuée car elle ne contribue que très peu à la réalisation de diagnostics, mais selon certains, elle a un rendement supérieur à la TDM (1).

La PET (positron emission tomography) peut également être utile dans la détection de l'étiologie de la fièvre. La PET montre des zones à forte activité métabolique qui sont des zones d'inflammation et d'infection.

Une **biopsie** est nécessaire si une anomalie est suspectée au niveau de tissus pouvant être biopsiés (p. ex., le foie, la moelle osseuse, la peau, la plèvre, les ganglions, les intestins ou les muscles). Les prélèvements biopsiques doivent être examinés sur le plan anatomopathologique et mis en culture pour rechercher des bactéries, des champignons, des virus et des mycobactéries ou pour des examens moléculaires (PCR). Une biopsie musculaire ou de peau d'une éruption peut confirmer une vascularite. La biopsie bilatérale de l'artère temporale peut confirmer une artérite à cellules géantes chez les patients âgés ayant une élévation inexplicée de la VS.

Référence pour les tests

1. [Fisher RE, Drews AL, Palmer EL](#). Lack of clinical utility of labeled white blood cell scintigraphy in patients with fever of unknown origin. *Open Forum Infect Dis*. 2022;9(3):ofac015, 2022.
doi:10.1093/ofid/ofac015

Traitement de la fièvre d'origine inconnue

Le traitement de la fièvre d'origine inconnue doit être centré sur le trouble initial.

Les antipyrétiques doivent être utilisés judicieusement, considérant la durée de fièvre.

Bases de gériatrie: fièvre d'origine inconnue

Les étiologies des fièvres d'origine inconnue chez les patients âgés sont habituellement similaires à celles observées dans la population générale, mais un trouble rhumatismal systémique est plus souvent

identifié. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes

- [Artérite à cellules géantes](#)
- [Lymphomes](#)
- [Abscess](#)
- [Tuberculose](#)

Points clés

- La fièvre d'origine inconnue classique est définie par une température corporelle $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ par voie rectale depuis > 3 semaines sans cause identifiée après 3 jours d'hospitalisation pour bilan ou ≥ 3 consultations ambulatoires.
- Les causes identifiées peuvent être classées comme infectieuses, rhumatologiques, néoplasiques ou diverses.
- Le bilan repose sur la synthèse des antécédents et l'examen clinique, avec une attention particulière à la recherche de facteurs de risque et des causes probables selon les circonstances individuelles.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.